KARLYON ENTERPRISE S.A.

(Soluções Académicas e Empresariais Aplicadas)

Entidade Formadora: ENCORP • Curso de CPD (Desenvolvimento Profissional Contínuo)

Estabilização de pacientes

Comunicação, passagem de turno e reavaliação

Aula 6 de 6 · 1 hora

Coordenador: Sacaita Manuel Inácio

Formação não qualificante, de carácter habilitante

Comunicação, passagem de turno e reavaliação

No final desta aula o formando deve ser capaz de:

Comunicar o doente crítico com clareza, passar o turno em segurança e reavaliar de forma contínua.

Estabilizar um doente não termina quando as primeiras medidas estão feitas: é preciso comunicar bem, passar o turno com segurança e reavaliar de forma contínua. A maioria dos erros graves nos cuidados tem origem em falhas de comunicação.

Nesta aula aprende a estruturar a informação, a conduzir uma passagem de turno e a…

Roteiro

1. O que vai aprender nesta aula
2. Porque a comunicação é tão importante
3. SBAR: relembrar
4. Outras ferramentas de comunicação
5. Passagem de turno segura
6. O que não pode faltar na passagem
7. Reavaliar: quando e como
8. Frequência de vigilância e NEWS2
9. Registar a evolução
10. Barreiras à comunicação
11. Caso: passagem de turno
12. Caso: resolução
13. Erros frequentes
14. Pontos-chave
15. Para reflectir
16. Para aprofundar

O que vai aprender nesta aula

No final desta aula será capaz de:

1. Explicar a importância da comunicação na segurança do doente
2. Usar SBAR e outras ferramentas de comunicação estruturada
3. Conduzir uma passagem de turno clara e completa
4. Planear e registar a reavaliação do doente crítico
5. Reconhecer barreiras à comunicação e como as ultrapassar

Porque a comunicação é tão importante

- Falhas de comunicação estão entre as principais causas de eventos adversos
- O doente crítico muda depressa: a informação tem de ser **actual**
- Várias pessoas cuidam do mesmo doente: sem comunicação, perde-se informação
- Comunicar bem poupa tempo, evita erros e salva vidas

> **Regra:** informação **clara, completa, curta e confirmada**.

SBAR: relembrar

Letra	Conteúdo
S	Situação: quem sou, que doente, qual o problema
B	Antecedentes: motivo da admissão, doenças, medicação, alergias
A	Avaliação: sinais vitais, ABCDE, tendência

Outras ferramentas de comunicação

Ferramenta	Para quê
Repetição em voz alta (*read-back*)	Confirmar ordens e valores
Fecho do ciclo	Quem recebeu confirma; quem pediu verifica que foi feito
Nome e função	Identificar-se: «Sou o enfermeiro X, da enfermaria Y»
Pedir ajuda cedo	Evitar que o doente se agrave
Ferramentas escritas	Quadros, gráficos, registos

Em emergência, use **ordens curtas e directas**, dirigidas a uma pessoa pelo nome.

Passagem de turno segura

1

Faça-a junto ao doente ou num local calmo, sem interrupções

2

Use uma estrutura fixa (por exemplo SBAR)

3

Comece pelos doentes mais graves ou instáveis

Inclua

diagnóstico, estado actual, tendência, o que foi feito, o que falta fazer e o que vigiar

5

Confirme alergias, acessos, drenos, oxigénio e medicação em curso

6

Deixe perguntas para esclarecer e registe

O que não pode faltar na passagem

Item	Exemplo
Identificação	Nome, idade, cama, diagnóstico
Estado actual	ABCDE, sinais vitais e NEWS2
Tendência	Estável, a melhorar ou a agravar
Intervenções	Oxigénio, fluidos, medicação, procedimentos
Pendentes	Exames, avaliações médicas, reavaliações
Alertas	Quando chamar e quem, preferências do doente

Reavaliar: quando e como

Reavalie **sempre**:

- Depois de cada intervenção (oxigénio, fluidos, analgesia)
- Quando o doente muda de aspecto ou de queixa
- Na frequência definida pelo protocolo e pela pontuação NEWS2
- Antes de passar o turno

Repita o **ABCDE** e compare com a avaliação anterior.

Frequência de vigilância e NEWS2

Pontuação NEWS2	Vigilância habitual (sugestão)
0	Pelo menos de 12 em 12 horas
1 a 4	Pelo menos de 4 a 6 horas
5 ou mais (ou 3 num parâmetro)	De hora a hora ou monitorização contínua e alerta urgente
7 ou mais	Monitorização contínua e resposta de emergência

Atenção: a frequência real deve seguir o protocolo local e a avaliação clínica.

Registar a evolução

- Registe **valores, hora e tendência**
- Registe intervenções e **resposta** do doente
- Anote a quem comunicou, a que horas e o que foi decidido
- Use gráficos e listas de verificação quando existirem
- Mantenha os registos **legíveis, objectivos e sem rasuras**

Barreiras à comunicação

Barreira	Como ultrapassar
Ruído e interrupções	Local calmo, pedir silêncio
Hierarquias	Sentir-se à vontade para falar; usar «preciso de ajuda»
Pressa	Estrutura SBAR e pontos-chave
Linguagem técnica excessiva	Explicar siglas e termos
Medo de incomodar	Chamar cedo: o doente é a prioridade

Caso: passagem de turno

No fim do turno da manhã, a enfermeira passa um doente de 72 anos com pneumonia, mas diz apenas: «Está estável, tem oxigénio.» No início da tarde, o doente tem FR 28 e SpO_2 88%.

> **Pense antes de avançar:** o que faltou na passagem?

Caso: resolução

Faltou **informação concreta**:

- Qual era a SpO_2 e que oxigénio estava a fazer
- **Tendência** (a FR vinha a subir?)
- Pendentes: exames, reavaliação médica, antibiótico em falta
- Alertas: «chamar se SpO_2 abaixo de 92%»

Com SBAR e dados, o colega teria reconhecido o agravamento **mais cedo**.

Erros frequentes

- Passar turno de forma vaga («está bem»)
- Omitir pendentes ou alertas
- Não confirmar que a mensagem foi entendida
- Interromper a passagem por tarefas não urgentes
- Não reavaliar depois de uma intervenção
- Ter medo de pedir ajuda cedo

Pontos-chave

1. Comunique de forma clara, completa, curta e confirmada
2. SBAR estrutura a informação
3. Confirme ordens e valores em voz alta
4. Passe o turno junto ao doente, começando pelos mais graves
5. Reavalie depois de cada intervenção e conforme a NEWS2
6. Registe tendência, intervenções e resposta

Para reflectir

Discuta com um colega ou com o seu orientador:

? Como é a passagem de turno no seu serviço e o que poderia melhorar?

? Que informação lhe faltou alguma vez ao receber um doente?

? Que barreiras o impedem de pedir ajuda cedo?

Para aprofundar

Consulte no ENCORP:

→ NEWS2: escala de alerta precoce

→ Avaliação primária ABCDE

PRÓXIMO PASSO

Teste de avaliação

- 10 perguntas de escolha múltipla
- Nota mínima de aprovação: 70%
- Reveja os pontos-chave antes de começar
- Pode repetir o teste as vezes que quiser